SALVEAZĂ CAZUL BLOCAT™ · MATERIAL PRINCIPAL

60 de scenarii pentru cazuri blocate: Simptom → Cauză probabilă → Acțiune

Pentru acele cazuri care stagnează la jumătatea tratamentului: identifică simptomul, exclude cauzele pe rând, alege un singur pas și știi când să ceri o opinie avizată.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să utilizezi: protocolul de deblocare în 5 pași

Indexul celor 60 de scenarii

Capitolul 01 · Spațiul nu se închide

Capitolul 02 · Linia mediană nu se corectează

Capitolul 03 · Ocluzia nu răspunde

Capitolul 04 · Pierderea ancorajului

Capitolul 05 · Recidiva ocluziei deschise

Capitolul 06 · Ocluzia adâncă nu se ameliorează

Capitolul 07 · Recidiva rotației

Capitolul 08 · Dintele inclus nu erupe

Capitolul 09 · Suspiciune de rezorbție radiculară

Capitolul 10 · Lipsa purtării elasticelor

Capitolul 11 · Probleme cu aparatul

Capitolul 12 · Aliniatorul nu se adaptează

Capitolul 13 · Puncte de contact și rădăcini la finisare

Capitolul 14 · Probleme transversale

Capitolul 15 · Probleme parodontale și de igienă

MODULUL START

Cum să utilizezi

Între doi pacienți: caută simptomul, deschide fișa, urmează pașii.

> *Un caz este considerat blocat dacă aceeași valoare măsurată nu se modifică la două controale consecutive sau se modifică într-o direcție neașteptată. În acest manual, fiecare scenariu are aceeași structură.*

CÂMP	SCOP
Simptom	Ceea ce vezi sau măsori pe scaun.
Cauze probabile	2–4 cauze, ordonate de la cea mai frecventă.
Ce să verifici	Punctele prin care poți izola cauza. Bifează căsuțele.
Acțiuni	Pași de urmat secvențial. Modifică o singură variabilă odată.
Opinie avizată	Când să apelezi la altă specialitate sau la un specialist.

Protocol de deblocare în 5 pași

1. **Măsoară.** Înregistrează overjet-ul, overbite-ul, linia mediană, spațiul și relația folosind aceleași repere.
2. **Denumește simptomul.** Caută în index scenariul corespunzător.
3. **Exclude cauzele pe rând.** Întâi complianța și integritatea aparatului, apoi mecanica, la final biologia și diagnosticul.
4. **Modifică o singură variabilă.** Dacă schimbi mai multe lucruri simultan, nu vei ști ce a funcționat.
5. **Înregistrează și măsoară din nou după două controale.** Dacă nu există progres, reconstruiește diagnosticul și planul pornind de la lista de probleme.

Semnale de alarmă: oprește-te și analizează

- Mobilitate crescută, discromie, suspiciune de scurtare a rădăcinilor
- Dinte care nu se mișcă deloc (suspiciune de anchiloză)
- Recesiune gingivală, pungi parodontale adânci, plagă care nu se vindecă
- Durere ATM, blocaj, deschidere limitată a gurii

În aceste situații, nu crește forța; evaluează, înregistrează și, dacă este necesar, cere o opinie avizată.

Despre forțe și dozaj

Acest manual nu oferă valori de forță sau dozaje medicamentoase. Alegerea forței este o decizie clinică ce depinde de dinte, rădăcină, os și pacient.

MODULUL INDEX

Indexul celor 60 de scenarii

Caută simptomul, mergi la numărul corespunzător.

NR.	SCENARIU
F01	**Spațiul nu se închide**
01	Spațiul de extracție rămâne neschimbat de la un control la altul
02	Spațiul închis se redeschide după îndepărtarea lanțului
03	Diastema centrală se închide, apoi se redeschide
04	Incisivii s-au verticalizat excesiv în timpul închiderii spațiului
05	Spațiul s-a închis pe o parte, dar nu și pe cealaltă
F02	**Linia mediană nu se corectează**
06	Linia mediană dentară nu se îmbunătățește în ciuda mecanicii aplicate
07	În timpul corecției liniei mediane, o parte a alunecat în Clasa II
08	Linia mediană s-a îmbunătățit, apoi a recidivat
09	Liniile mediane superioară și inferioară deviază în direcții opuse
F03	**Ocluzia nu răspunde la tratament**
10	Relația molară nu se modifică în ciuda utilizării elasticelor de Clasa II
11	Overjet-ul scade, dar numai prin proclinarea incisivilor inferiori
12	După aparatul funcțional, Clasa II pare rezolvată, dar există o ocluzie dublă
13	În camuflajul de Clasa III, overjet-ul invers nu se închide
14	Clasa II s-a îmbunătățit, dar overjet-ul crește din nou după renunțarea la aparat
F04	**Pierderea ancorajului**
15	Molarul superior s-a mezializat, spațiul s-a epuizat înainte de închiderea overjet-ului
16	Mini-implantul este mobil sau a căzut
17	În timpul nivelării, incisivii inferiori s-au înclinat mai mult decât s-a planificat
18	Pierderea ancorajului în ciuda utilizării arcului transpalatinal sau a butonului Nance
F05	**Recidiva ocluziei deschise**
19	Ocluzia deschisă frontală s-a accentuat în timpul nivelării
20	Ocluzia deschisă s-a închis, apoi s-a redeschis
21	Ocluzie deschisă laterală: lipsa contactului pe premolari
22	Ocluzia frontală s-a deschis după utilizarea elasticelor sau a expansiunii
F06	**Ocluzia adâncă nu se îmbunătățește**

NR.	SCENARIU
23	Ocluzia adâncă nu se deschide în ciuda nivelării
24	Incisivii superiori fracturează bracketii inferiori
25	Ocluzia adâncă s-a îmbunătățit, dar s-a adâncit din nou la finalizare
26	Ocluzie adâncă cu zâmbet gingival: intruzia incisivilor superiori nu avansează
F07	**Recidiva rotației**
27	Rotația nu se corectează nici după schimbarea arcurilor
28	Rotația s-a corectat, dar a revenit la următorul control
29	Recidiva rotației în perioada de contenție
30	Punctul de contact adiacent s-a deschis în timpul corecției rotației
F08	**Dintele inclus nu erupe**
31	Caninul inclus nu răspunde la tracțiune
32	Incisivul adiacent a devenit mobil în timpul tracțiunii
33	Există spațiu, dar premolarul sau al doilea molar nu erupe
34	Probleme gingivale pe dintele tractat
F09	**Suspiciune de rezorbție radiculară**
35	Rădăcinile incisivilor par scurte pe radiografia panoramică de control
36	Mobilitatea dinților a crescut în timpul tratamentului
37	Modificarea culorii sau sensibilitate la un dinte cu istoric de traumatism
F10	**Nerespectarea purtării elasticelor**
38	Pacientul nu poartă elasticele
39	Pacientul poartă elasticele, dar în configurație greșită
40	Elasticul se rupe constant sau pacientul renunță din cauza durerii
41	Pacient care lipsește de la programări: se pierde controlul asupra cazului
F11	**Probleme cu aparatul**
42	Expansiunea așteptată nu a avut loc după RME
43	Recidivă transversală după expansiune
44	Pacientul nu poartă aparatul funcțional mobil
45	Aparatul funcțional fix se slăbește sau se rupe repetat
46	Arcul transpalatinal sau butonul Nance se înfige în mucoasă
F12	**Aliniatoarele transparente nu se adaptează**
47	Aliniatorul nu se așază complet pe dinți
48	Attachment-ul s-a dezlipit sau s-a tocit
49	Rotația sau extruzia planificată nu se realizează
50	Timpul de purtare a aliniatoarelor este scăzut
F13	**Puncte de contact și rădăcini la finalizare**

NR.	SCENARIU
51	Punctele de contact rămân deschise
52	Rădăcinile nu sunt paralele pe radiografia panoramică
53	Crestele marginale nu sunt la același nivel
54	Ocluzia posterioară nu se stabilizează
F14	**Probleme transversale**
55	Ocluzia inversă posterioară nu se corectează
56	Ocluzia în foarfecă nu se corectează
57	Lățimea arcului a crescut excesiv în timpul nivelării
F15	**Probleme parodontale și de igienă**
58	Leziuni de tip „white spot” au apărut în jurul bracketului
59	Hipertrofia gingivală împiedică mecanica
60	Recesiune gingivală pe suprafața vestibulară a incisivilor inferiori

MODULUL 01

Spațiul nu se închide

Spațiu de extracție și diastemă: valoarea nu se modifică, se redeschide sau se mișcă dinții greșiți.

Dacă spațiul nu se închide, nu te uita prima dată la mecanică, ci la calea de glisare și la ocluzie. Obstacolul este de cele mai multe ori în arc, nu în forță.

Greșeală frecventă

Începerea închiderii spațiului înainte de finalizarea nivelării. Pe un arc curbat, niciun dinte nu glisează corect.

CAZUL 01

Spațiul de extracție rămâne constant de la un control la altul

Simptom: Lanțul elastic sau arcul de închidere par active, dar dimensiunea spațiului nu s-a modificat de două-trei controale.

CAUZE POSIBILE

- Închiderea a început înainte de finalizarea nivelării; arcul este curbat pe calea de glisare sau nu este suficient de rigid.
- Frecare: ligatură strânsă, arc agățat în aripioarele bracketului, îndoituri sau stopuri pe arc.
- Pierderea forței: lanțul nu a fost schimbat de mult timp.
- Obstacol ocluzal: dintele din arcul antagonist atinge dintele care glisează.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Arcul stă pasiv în slotul bracketelor?
- [ ] Există îndoituri, stopuri sau sertizări pe calea de glisare?
- [ ] Când a fost schimbat ultima dată lanțul sau arcul?
- [ ] Există contact ocluzal prematur pe dintele care glisează?
- [ ] Cum este starea gingiei și a osului în zona spațiului?

ACȚIUNI

1. Verifică dacă nivelarea este finalizată; dacă nu, revino la faza anterioară a arcului.
2. Curăță calea de glisare: elimină îndoiturile, stopurile și ligaturile rupte.
3. În caz de obstacol ocluzal, planifică o înălțare de ocluzie temporară sau eliminarea punctului de contact.
4. Reînnoiește activarea și păstrează intervalul de control scurt.
5. După două controale, măsoară din nou de la aceleași puncte de referință și notează.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă observi pungi parodontale adânci, defecte osoase sau recesiuni gingivale la nivelul spațiului, cere opinia unui parodontolog. Dacă există suspiciunea că rădăcina se lovește de corticala osoasă, ia în considerare investigații imagistice suplimentare.

CAZUL 02

Spațiul închis se redeschide după îndepărtarea lanțului

Simptom: Spațiul care părea închis la control s-a redeschis până la următorul control.

CAUZE POSIBILE

- După închidere, dinții nu au fost solidarizați (nu există contenție pasivă).
- Rădăcinile nu sunt paralele; doar coroanele s-au înclinat.
- Interpoziție linguală sau obicei vicios labial.
- Forță prea mare și mișcare prea rapidă în timpul închiderii.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Paralelismul rădăcinilor pe radiografia panoramică (OPG).
- [ ] Sunt solidarizați dinții care au fost închiși?
- [ ] Poziția limbii și tiparul de deglutiție.
- [ ] Dimensiunea arcului este suficientă pentru controlul torque-ului și al rădăcinilor?

ACȚIUNI

1. Solidarizează pasiv segmentul închis.
2. Evaluează paralelismul rădăcinilor; dacă este necesar, corectează poziția bracketului și oferă timp pentru mișcarea radiculară.
3. Continuă închiderea pe un arc mai rigid, în mod controlat.
4. Dacă există un obicei vicios, explică-i pacientului și notează.
5. Înainte de finalizare, actualizează planul de contenție pentru această regiune.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de interpoziție linguală marcată și tulburări de deglutiție asociate, trimite pacientul pentru o evaluare miofuncțională la specialistul corespunzător.

CAZUL 03

Diastema centrală se închide, apoi se redeschide

Simptom: Spațiul dintre incisivii centrali superiori se închide, dar se redeschide după câteva săptămâni.

CAUZE POSIBILE

- Fren labial gros sau cu inserție joasă.
- Discrepanță Bolton: incisivii superiori sunt relativ mici.
- Pierderea suportului parodontal sau proclinația incisivilor.
- Dinte supranumerar sau patologie pe linia mediană.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Testul de tracțiune a frenului: se albește papila?
- [ ] A fost efectuată analiza Bolton?
- [ ] Radiografia regiunii mediane.
- [ ] Înclinarea incisivilor și overjet-ul.
- [ ] Sondajul parodontal.

ACȚIUNI

1. Exclude patologia mediană și dinții supranumerari prin radiografie.
2. Efectuează analiza Bolton; include discrepanța de mărime dentară în planificarea tratamentului.
3. Închide spațiul și solidarizează pasiv incisivii.
4. În caz de suspiciune de fren, planifică momentul intervenției împreună cu colegul specialist.
5. Ia în considerare contenția linguală fixă în planul de retenție.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Evaluare chirurgicală pentru fren, chirurgie orală în caz de suspiciune de dinte supranumerar sau chist; parodontologie în caz de pierdere a suportului parodontal.

CAZUL 04

Incisivii s-au verticalizat excesiv în timpul închiderii spațiului

Simptom: Spațiul se închide, dar incisivii superiori sunt retrudați și verticalizați; overbite-ul se adâncește, iar zâmbetul devine plat.

CAUZE POSIBILE

- Arcul nu umple slotul; nu există control al torque-ului.
- Forța de retracție a acționat fără control radicular în timpul retracției frontale.
- S-a planificat ancoraj maxim, dar dinții frontali s-au deplasat mai mult decât s-a prevăzut.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Înclinarea incisivilor: valoarea inițială și cea actuală (U1-SN).
- [ ] Dimensiunea și materialul arcului utilizat.
- [ ] Modificarea overbite-ului.
- [ ] Vizibilitatea incisivilor în timpul zâmbetului.

DE FĂCUT

1. Oprește retracția și recuperează torque-ul.
2. Folosește un arc care ocupă mai bine slotul, cu aplicare de torque dacă este necesar.
3. Închide spațiul restant după ce ai asigurat controlul radicular.
4. Tratează concomitent adâncirea ocluziei (vezi capitolul 06).
5. Documentează progresul cu control cefalometric.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă există suspiciunea că suprafața radiculară este presată pe corticala osoasă, solicită investigații imagistice suplimentare și opinia unui ortodont cu experiență.

CAZUL 05

Spațiul s-a închis pe o parte, dar nu și pe cealaltă

Simptom: Spațiul de extracție se închide cu ritmuri diferite pe partea dreaptă și stângă; linia mediană începe să se devieze.

CAUZE POSIBILE

- Frecare diferită sau activare inegală pe cele două părți.
- Obstacol ocluzal sau ocluzie inversă pe o parte.
- Densitate osoasă sau morfologie radiculară diferită.
- Ancorajul nu a fost planificat identic pe ambele părți.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Activarea și lungimea lanțului pe ambele părți
- [ ] Contactele ocluzale pe fiecare parte
- [ ] Unde este linia mediană față de punctul de plecare?
- [ ] Morfologia radiculară și osul pe radiografia panoramică (OPG)

DE FĂCUT

1. Legați pasiv partea închisă și concentrează-te pe partea care nu se închide.
2. Elimină obstacolul de pe partea care nu se închide (vezi verificările de la cazul 1).
3. Dacă este necesar, planifică un ancoraj auxiliar unilateral.
4. Înregistrează linia mediană la fiecare control folosind aceeași referință.
5. Dacă asimetria persistă, reface planul pornind de la lista de probleme.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de suspiciune de anchiloză (sunet metalic la percuție, dintele nu se mișcă deloc), consultă capitolul din Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză și, dacă este necesar, cere opinia unui medic specialist.

MODULUL 02

Linia mediană nu se corectează

Deviația liniei mediane dentare nu răspunde la mecanică, ocluzia se agravează în timpul corecției sau revine la starea inițială.

În cazul deviației liniei mediane, prima întrebare este: deviația este dentară, scheletală sau funcțională? Mecanica nu oferă răspunsuri la întrebări greșite.

Greșeală frecventă

Determinarea arcului incorect fără a-l raporta la linia mediană facială, ci doar privind dinții.

CAZUL 06

Linia mediană dentară nu se îmbunătățește în ciuda mecanicii

Simptom: În ciuda mecanicii asimetrice, linia mediană a rămas în același loc de luni de zile.

CAUZE POSIBILE

- Deviația este scheletală (asimetrie mandibulară), mecanica rămâne la nivel dentar.
- Alunecare funcțională: mandibula deviază lateral din cauza unui contact prematur.
- Sursa deviației a fost identificată pe arcul greșit.
- Nu există spațiu pe una dintre părți; nu există loc pentru mișcare.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Linia mediană dentară superioară și inferioară față de linia mediană facială
- [ ] Linia mediană cu gura deschisă și în relație centrică
- [ ] Locul contactului prematur
- [ ] Analiza spațiului pe fiecare parte

DE FĂCUT

1. Reevaluează pacientul în relație centrică.
2. În caz de alunecare funcțională, rezolvă mai întâi contactul prematur și problema transversală.
3. Redetermină pe care arc se află deviația și direcționează mecanica către acesta.
4. Calculează spațiul necesar pentru mișcare (IPR, spațiu, plan de extracție).
5. În caz de asimetrie scheletală, redefinesc obiectivul în limitele camuflajului ortodontic.

Când să ceri o opinie de specialitate: În caz de asimetrie scheletală marcată, deviație mandibulară sau diagnostic ATM, efectuează o evaluare comună cu un chirurg oro-maxilo-facial.

CAZUL 07 În timpul îmbunătățirii liniei mediane, o parte a alunecat în Clasa II

Simptom: Linia mediană se îmbunătățește, dar relația canină și molară se deteriorează pe partea cu elastice.

CAUZE POSIBILE

- Elasticul unilateral cauzează o mișcare nedorită pe partea opusă.
- Ancorajul este slab pe una dintre părți.
- Deviația liniei mediane provine, de fapt, dintr-o asimetrie sagitală.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Relația canină și molară pe fiecare parte
- [ ] Configurația elasticelor și timpul de purtare
- [ ] Planul de ancoraj
- [ ] Forma arcului este simetrică?

DE FĂCUT

1. Relația canină trebuie să fie prioritară; nu viza doar linia mediană în sine.
2. Replanifică elasticele astfel încât să îmbunătățească relația care se deteriorează.
3. Dacă este necesar, folosește un ancoraj auxiliar unilateral.
4. Verifică simetria formei arcului cu un șablon.
5. Înregistrează relația pe fiecare parte la fiecare control.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă asimetria sagitală este scheletală, iar camuflajul ar afecta estetica facială, ia în considerare planificarea comună cu chirurgul.

CAZUL 08 Linia mediană s-a îmbunătățit, apoi a revenit la starea inițială

Simptom: La controlul anterior liniile mediane coincideau, acum sunt din nou deviate.

CAUZE POSIBILE

- La renunțarea la elastice, dinții revin în poziția anterioară.
- Rădăcinile nu s-au deplasat, doar coroanele s-au înclinat.
- Contactul prematur sau ocluzia inversă persistă.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Angulările rădăcinilor pe radiografia panoramică
- [ ] Contactele ocluzale și derapajele
- [ ] Cum a întrerupt pacientul purtarea elasticelor?

ACȚIUNI

1. Corectează angulările rădăcinilor; dacă este necesar, repoziționează bracketul.
2. Nu întrerupe brusc purtarea elasticelor, ci gradual.
3. Echilibrează contactele ocluzale.
4. Menține corecția pe parcursul mai multor controale și stabilizează.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă derapajul este însoțit de simptome ATM, trimite pacientul pentru evaluarea ATM la specialistul corespunzător.

CAZUL 09

Liniile mediane superioară și inferioară sunt deviate în direcții opuse

Simptom: O linie mediană este deviată spre dreapta, cealaltă spre stânga; corectarea uneia o agravează pe cealaltă.

CAUZE POSIBILE

- Discrepanță de mărime dentară (Bolton).
- Dinte lipsă, microdont sau supranumerar.
- Extracție asimetrică sau înghesuire asimetrică.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Analiza Bolton
- [ ] Dinte lipsă sau microdont
- [ ] Înghesuire pe fiecare parte
- [ ] Linia mediană facială

ACȚIUNI

1. Măsoară deviația fiecărei arcade separat față de linia mediană facială.
2. Evaluează discrepanța de mărime dentară împreună cu IPR sau un plan restaurator.
3. Corectează mai întâi arcada cu deviația mai mare.
4. Discută cu pacientul faptul că deviația reziduală poate rămâne în limite acceptabile la finalizare.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă este necesară restaurarea dinților microdonți sau lipsă, elaborează un plan comun cu medicul stomatolog/protetician.

MODULUL 03

Ocluzia nu răspunde

Corecția Clasei II și III nu produce răspunsul așteptat sau răspunsul apare doar la nivelul dinților.

Dacă corecția sagitală stagnează, verifică în ordine: complianța, mecanica, creșterea, diagnosticul. Majoritatea blocajelor se află în primele două.

Greșeală frecventă

Să urmărești relația molară, dar să nu stabilizezi relația canină și înclinația incisivilor.

CAZUL 10

Relația molară nu se modifică în ciuda elasticelor de Clasa II

Simptom: Pacientul afirmă că poartă elasticele; relația molară și canină este aceeași de luni de zile.

CAUZE POSIBILE

- Pacientul nu poartă elasticele suficient timp.
- Arcurile nu sunt suficient de rigide pentru a susține elasticele.
- Spațiu rezidual pe arcada superioară sau ancoraj insuficient.
- Problema este scheletală, la limita camuflajului ortodontic.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Uzura elasticelor, cârligele și raportul pacientului
- [ ] Dimensiunea și materialul arcului
- [ ] Overjet și relația canină (mm)
- [ ] Stadiul de creștere

ACȚIUNI

1. Discută deschis cu pacientul despre complianță și oferă un calendar de purtare.
2. Folosește elasticele pe arcuri rigide.
3. Reevaluează ancorajul; dacă este necesar, planifică ancoraj suplimentar.
4. Măsoară după două controale; dacă nu există progres, reevaluează diagnosticul.

Când să ceri o opinie de specialitate: Dacă discrepanța scheletală depășește limita camuflajului, efectuează o evaluare comună cu chirurgul pentru chirurgie ortognată.

CAZUL 11 Overjet-ul scade, dar doar incisivii inferiori se deplasează anterior

Simptom: Overjet-ul se îmbunătățește, relația molară nu se modifică; incisivii inferiori par protrudați.

CAUZE POSIBILE

- Efectul elasticelor pe arcada inferioară se concentrează pe incisivi.
- Ancoraj insuficient pe arcada inferioară.
- Înclinația incisivilor inferiori era mare încă de la început.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] IMPA: valoarea inițială și actuală
- [ ] Gingia și osul pe suprafața vestibulară a incisivilor inferiori
- [ ] Controlul torque-ului pe arcada inferioară

ACȚIUNI

1. Ține sub control înclinația incisivilor inferiori; folosește un arc care asigură controlul torque-ului.
2. Întărește ancorajul pe arcada inferioară.
3. Revizuiește planul de utilizare a elasticelor.
4. Dacă înclinația incisivilor a atins limita, discută din nou scopul camuflajului.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă pe suprafața vestibulară a incisivilor inferiori gingia s-a subțiat sau a început o recesiune, cere o opinie parodontologică.

CAZUL 12 După aparatul funcțional, Clasa II pare rezolvată, dar există o ocluzie dublă

Simptom: Clasa I în ocluzie propulsată, Clasa II în poziție de repaus; suspiciune de ocluzie dublă.

CAUZE POSIBILE

- Mandibula este menținută anterior postural, nu scheletal.
- Poziția condilului nu este stabilă.
- Evaluarea nu a fost efectuată în relație centrică.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Overjet în relație centrică și în ocluzie de repaus
- [ ] Palparea musculară și constatările ATM
- [ ] Modificarea ANB pe cefalometrie

DE FĂCUT

1. Înregistrează un nou status în relație centrică.
2. Diferențiază corecția reală de cea posturală și notează-le.
3. Înainte de faza de fixare, asigură-te că relația este stabilă.
4. Dacă este necesar, prelungește faza funcțională sau reevaluează planul.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de dureri la nivelul ATM, blocaje sau zgomote articulare evidente, trimite pacientul pentru o evaluare a ATM la specialistul corespunzător.

CAZUL 13 În camuflajul de Clasa III, overjet-ul invers nu se închide

Simptom: Ocluzia inversă frontală persistă; incisivii sunt mai înclinați decât s-a planificat.

CAUZE POSIBILE

- Problema este scheletală, la limita camuflajului.
- Pacientul este încă în creștere.
- Există o alunecare funcțională care nu a fost evaluată.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Contactul marginii incizale în relație centrică
- [ ] Înclinația incisivilor superiori și inferiori
- [ ] Stadiul de creștere și istoricul familial
- [ ] Modificarea profilului

DE FĂCUT

1. Diferențiază dacă există o alunecare funcțională.
2. Stabilește limita înclinației incisivilor și nu o depăși.
3. Dacă creșterea continuă, adaptează planul în consecință.
4. Dacă camuflajul nu este suficient, discută din nou opțiunile cu pacientul și familia.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă Clasa III este scheletală și creșterea este activă, sau dacă ai depășit limita camuflajului, planifică tratamentul împreună cu un chirurg.

CAZUL 14 Clasa II s-a îmbunătățit, dar după renunțarea la aparat overjet-ul crește din nou

Simptom: La controalele de după aparat, overjet-ul crește treptat.

CAUZE POSIBILE

- Corecția a fost obținută prin compensare dentară.
- Tiparul de creștere continuă nefavorabil.
- În perioada de tranziție nu s-a utilizat un aparat de contenție.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Măsurătorile seriate ale overjet-ului și relației molare
- [ ] Închiderea labială și obiceiurile vicioase
- [ ] Planul de tranziție

DE FĂCUT

1. Planifică un aparat de contenție pentru perioada de tranziție.
2. Notează modificarea overjet-ului la fiecare control.
3. Introdu mecanica de Clasa II în faza de fixare.
4. Discută din nou cu pacientul despre obiectivul planificat.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de recidivă scheletală marcată, efectuează o evaluare comună cu un ortodont experimentat.

MODULUL 04

Pierderea ancorajului

Dinții de ancoraj s-au deplasat mai mult decât s-a planificat; spațiul s-a epuizat sau incisivii s-au deplasat într-o direcție nedorită.

Imediat ce observi pierderea ancorajului, măsoară și recalculează spațiul restant. Întârzierea limitează opțiunile.

Greșeală frecventă

A nu nota necesarul de ancoraj la începutul tratamentului; a nu ști ulterior ce s-a pierdut.

CAZUL 15

Molarul superior s-a mezializat, spațiul s-a epuizat înainte ca overjet-ul să se închidă

Simptom: Spațiul de extracție s-a închis, dar overjet-ul este încă mare; relația molară a alunecat spre Clasa II.

CAUZE POSIBILE

- Era necesar un ancoraj maxim, dar s-a planificat unul mediu.
- În timpul nivelării, molarii s-au înclinat spre mezial.
- Dinții frontali nu au fost retrași cu control radicular.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Relația molară inițială și actuală
- [ ] Overjet restant (mm)
- [ ] Angularea molarilor
- [ ] Documentația planului de ancoraj

DE FĂCUT

1. Calculează spațiul restant și necesarul pentru overjet.
2. Planifică ancoraj suplimentar (mini-implant, mecanică de Clasa II).
3. Dacă este necesar, ia în considerare mecanica de distalizare a molarilor.
4. Discută din nou cu pacientul despre obiectiv și durata tratamentului.

Când să ceri o opinie de specialitate: Dacă planifici un mini-implant și există suspiciunea unor limitări anatomice, solicită imagistică suplimentară și opinia unui coleg experimentat.

CAZUL 16 Mini-implantul se mișcă sau a căzut

Simptom: La control, mini-implantul este mobil sau pacientul declară că a căzut.

CAUZE POSIBILE

- A fost plasat într-o zonă cu mucoasă mobilă.
- Proximitatea față de rădăcină.
- Inflamație în țesuturile înconjurătoare, igienă deficitară.
- Încărcare timpurie și excesivă după inserție.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Inflamația din jurul implantului
- [ ] Distanța față de rădăcinile adiacente
- [ ] Momentul începerii încărcării
- [ ] Igiena orală a pacientului

DE FĂCUT

1. Nu încărca implantul mobil; decide dacă trebuie îndepărtat.
2. Curăță zona și monitorizează vindecarea.
3. Alege noul loc de inserție pe baza distanței față de rădăcini și a țesuturilor.
4. Adaptează mecanica astfel încât să limiteze pierderea ancorajului chiar și fără implant.
5. Notează evenimentul și cauza probabilă în jurnal.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de infecție extinsă în jurul implantului, durere sau suspiciune de leziune radiculară, solicită evaluarea chirurgului oro-maxilo-facial.

CAZUL 17 În timpul nivelării, incisivii inferiori s-au înclinat spre vestibular mai mult decât s-a planificat

Simptom: Înghesuirea este rezolvată, dar incisivii inferiori sunt protrudați; profilul buzelor a avansat.

CAUZE POSIBILE

- Necesarul de spațiu a fost obținut prin proclinația incisivilor.
- IPR-ul sau extracția planificată nu au fost efectuate.
- Forma arcadei a fost expandată excesiv.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] IMPA: valoarea inițială și cea actuală
- [ ] Analiza spațiului actualizată
- [ ] Grosimea gingiei labiale
- [ ] Modificarea profilului

ACȚIUNI

1. Efectuează o nouă analiză a spațiului.
2. Reevaluează posibilitatea efectuării IPR-ului sau a extracției.
3. Apropie forma arcadei de forma inițială.
4. Gestionează înclinația incisivilor cu un arc care asigură controlul torque-ului.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de subțiere a gingiei labiale sau semne de recesiune, solicită un consult parodontal.

CAZUL 18

Pierderea ancorajului în ciuda utilizării arcului transpalatinal sau a butonului Nance

Simptom: Dispozitivul de ancoraj este la locul lui, dar molarii s-au mezializat.

CAUZE POSIBILE

- Banda s-a decolat, dispozitivul a rămas pasiv.
- Dispozitivul nu este suficient pentru necesarul de ancoraj.
- Forța aplicată pe segmentul frontal este mai mare decât cea planificată.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Adaptarea și cimentarea benzilor
- [ ] Adaptarea dispozitivului la țesuturi
- [ ] Măsurătorile în serie ale relației molare

ACȚIUNI

1. Verifică benzile și fixarea dispozitivului; înlocuiește-le dacă este necesar.
2. Redetermină necesarul de ancoraj; decide dacă este nevoie de ancoraj suplimentar.
3. Redu forța aplicată pe segmentul frontal.
4. Recalculează spațiul restant.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă există ulcerații sau hiperplazie tisulară pe mucoasa palatinală, tratează mai întâi țesutul; pentru leziuni care nu se vindecă, adresează-te medicului specialist corespunzător.

MODULUL 05

Recidiva ocluziei deschise

Ocluzia deschisă frontală sau laterală nu se închide, se agravează sau se redeschide după finalizarea tratamentului.

În cazul ocluziei deschise, caută cauza înainte de a aplica mecanica: obiceiuri vicioase, limbă, respirație, tipar de creștere. Dacă sursa nu este eliminată, ocluzia deschisă va recidiva.

Greșeală frecventă

Închiderea ocluziei deschise doar prin extruzia dinților, fără a documenta cauza.

CAZUL 19 Ocluzia deschisă frontală s-a accentuat în timpul nivelării

Simptom: Pe măsură ce nivelarea a avansat, deschiderea frontală a crescut.

CAUZE POSIBILE

- Dinții posteriori s-au extrudat, mandibulă a rotat posterior și inferior.
- Incisivii s-au intrudat în timpul nivelării curbei Spee.
- Interpoziția linguală sau suptul degetului continuă.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Măsurătorile în serie ale overbite-ului
- [ ] FMA și tiparul vertical
- [ ] Poziția limbii
- [ ] Obiceiurile vicioase în anamneză

ACȚIUNI

1. Oprește mecanica ce favorizează extruzia posterioară.
2. Alege arcurile având în vedere controlul vertical.
3. Discută despre obiceiul vicios cu pacientul și familia.
4. Evaluează alte opțiuni pentru controlul vertical (vezi Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale).

Când să ceri o opinie de specialitate: În caz de suspiciune de respirație orală sau vegetații adenoide, consult ORL; pentru interpoziție linguală, evaluare miofuncțională.

CAZUL 20 Ocluzia deschisă s-a închis, apoi s-a redeschis

Simptom: La finalizare, overbite-ul era pozitiv; la controale, a scăzut treptat la zero.

CAUZE POSIBILE

- A fost închisă prin mecanică, fără a trata interpoziția lingual ă.
- Închiderea a fost obținută doar prin extruzia incisivilor.
- Creșterea continuă în sens vertical.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Poziția limbii și deglutiția
- [ ] Vizibilitatea coroanelor incisivilor
- [ ] Modificarea verticală pe cefalometrie

ACȚIUNI

1. Măsoară și notează gradul recidivei.
2. Identifică cauza; dacă obiceiul vicios persistă, ocupă-te mai întâi de acesta.
3. Actualizează planul de contenție astfel încât să includă controlul vertical.
4. Dacă este necesar un retratament, stabilește obiective realiste.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În cazul ocluziei deschise scheletice pronunțate, evaluare comună cu chirurgul; pentru probleme de limbă și respirație, specialistul corespunzător.

CAZUL 21 Ocluzie deschisă laterală: lipsa contactului pe premolari

Simptom: Există contact frontal și molar; în regiunea premolarilor, dinții nu se ating.

CAUZE POSIBILE

- Poziționarea incorectă a bracketului (înălțime).
- Țesut moale interpus între dinți (obraz sau limbă).
- Tulburări de erupție sau anchiloză.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Înălțimea bracketurilor
- [ ] Interpoziție lingual ă laterală
- [ ] Nivelul rădăcinilor și al osului pe radiografia panoramică
- [ ] Sunetul la percuție

ACȚIUNI

1. Verifică înălțimea bracketurilor; repoziționează-le dacă este necesar.
2. Exclude suspiciunea de anchiloză.
3. La finalizare, planifică o mecanică ușoară de așezare (settling).
4. Corectează poziția limbii.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** La suspiciunea de anchiloză, consultă capitolul din Ghidul 4 · Traumă și anchiloză și, la nevoie, cere avizul unui medic specialist.

CAZUL 22

Zona frontală s-a deschis după elastice sau expansiune

Simptom: După elastice de Clasa a II-a sau după expansiune transversală, overbite-ul a scăzut.

CAUZE POSIBILE

- Elasticele au extruzat dinții posteriori.
- Prin expansiune, cuspizii posteriori au coborât.
- Tiparul vertical al pacientului este cu unghi mare.

CE VERIFICI

- [ ] FMA și tiparul vertical
- [ ] Extruzia molarilor și a premolarilor
- [ ] Direcția și timpul de purtare al elasticelor

DE FĂCUT

1. Reproiectează configurația elasticelor în funcție de dimensiunea verticală.
2. Verifică contactele ocluzale posterioare.
3. La nevoie, ia în calcul un ancoraj suplimentar pentru controlul vertical.
4. Notează modificarea overbite-ului la fiecare control.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** Dacă problema verticală este scheletală și progresivă, efectuează o evaluare comună cu un ortodont cu experiență.

CAPITOLUL 06

Ocluzia adâncă nu se îmbunătățește

Overbite-ul nu scade, ocluzia lovește brackeții inferiori sau se adâncește din nou la finalizare.

În cazul ocluziei adânci, decide mai întâi care dinte trebuie să se miște: incisivul superior, incisivul inferior sau dinții posteriori. Aceasta o determină zâmbetul și tiparul vertical.

Greșeală frecventă

Deschiderea oricărei ocluzii adânci cu aceeași mecanică; neconsemnarea vizibilității incisivilor în timpul zâmbetului.

CAZUL 23

Ocluzia adâncă nu se deschide în ciuda nivelării

Simptom: Arcurile au avansat, dar overbite-ul este aproape același.

CAUZE POSIBILE

- Curba lui Spee este adâncă; arcul nu o îndreaptă.
- Brackeții inferiori sunt într-o poziție care nu permite deschiderea incisivilor.
- Incisivii sunt verticali; lipsa torqului adâncește ocluzia.
- Pacientul are un tipar cu unghi mic și musculatură puternică.

CE VERIFICI

- [ ] Adâncimea curbei lui Spee
- [ ] Inclinațiile incisivilor
- [ ] Înălțimile brackeților
- [ ] FMA și tiparul muscular

DE FĂCUT

1. Notează intruzia sau extruzia căror dinți este necesară.
2. Planifică secvența de arcuri care îndreaptă controlat curba lui Spee.
3. Corectează torqul incisivilor; incisivii verticali adâncesc ocluzia.
4. La nevoie, ia în calcul un plan de ocluzie frontal sau un ancoraj suplimentar.

Când să ceri un aviz de specialitate: Dacă ocluzia adâncă este însoțită de durere la nivelul ATM sau de traumatism gingival, este necesară evaluarea medicului specialist potrivit.

CAZUL 24 Incisivii superiori desprind bracketii inferiori

Simptom: Bracketii incisivilor inferiori se desprind în mod repetat; pacientul spune că mușcă pe bracketi.

CAUZE POSIBILE

- Bracketii inferiori se află în calea închiderii.
- Bracketii au fost lipiți pe incisivii inferiori înainte de deschiderea overbite-ului.

CE VERIFICI

- [ ] Contactul cu bracketii la închidere
- [ ] Urme de uzură pe bracketi
- [ ] Overbite (mm)

DE FĂCUT

1. Planifică o ridicare temporară a ocluziei.
2. La nevoie, amână lipirea bracketilor inferiori până când overbite-ul scade.
3. După deschiderea overbite-ului, lipește bracketii la înălțimea corectă.
4. Informează pacientul despre alimentele dure.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** Dacă pe marginile incisale există fisură sau fractură, evaluare de odontoterapie conservatoare.

CAZUL 25 Ocluzia adâncă se îmbunătățise, dar s-a adâncit din nou la finalizare

Simptom: În faza de mijloc overbite-ul era normal; la controalele de finalizare a crescut.

CAUZE POSIBILE

- În timpul închiderii spațiilor, incisivii s-au verticalizat.
- La trecerea de la arcul rigid la cel flexibil s-a pierdut controlul.
- Unghiul interincisiv a crescut.

CE VERIFICI

- [ ] Inclinațiile incisivilor
- [ ] Măsurătorile seriate ale overbite-ului
- [ ] Secvența de arcuri

DE FĂCUT

1. Recuperează torqul incisivilor.
2. La finalizare, folosește un arc care păstrează controlul vertical.
3. Include controlul dinților frontali în planul de contenție.
4. Notează modificarea și, în cazul următor, urmărește evoluția torqului în timpul închiderii spațiilor.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** Dacă recidiva este rapidă și pronunțată, evaluează cazul împreună cu un ortodont cu experiență.

CAZUL 26

Ocluzie adâncă cu zâmbet gingival: intruzia incisivilor superiori nu avansează

Simptom: La zâmbet se vede multă gingie; incisivii superiori nu se intruzează.

CAUZE POSIBILE

- Mecanica de intruzie provoacă extruzia dinților posteriori.
- Incisivii sunt verticali; direcția forței nu este potrivită pentru intruzie.
- Cauza vizibilității gingiei nu este dentară (buză, os, gingie).

CE VERIFICI

- [ ] Vizibilitatea incisivilor și a gingiei la zâmbet
- [ ] Lungimea și mobilitatea buzei
- [ ] Lungimea coroanei incisivilor
- [ ] Extruzia posterioară

DE FĂCUT

1. Diferențiază cauza expunerii gingivale: dentară, scheletală sau de țesuturi moi.
2. Evaluează ancorajul suplimentar pentru intruzie.
3. Înainte de intruzie, corectează înclinația incisivilor.
4. Discută cu pacientul despre obiective realiste.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de coroană clinică scurtă sau exces gingival, parodontologie; în caz de exces vertical scheletal, evaluare comună cu chirurgul.

MODULUL 07

Recidiva rotației

Rotația nu se corectează, revine după îmbunătățire sau recidivează în timpul contenției.

Rotația este mișcarea care recidivează cel mai frecvent. Corectează-o precoce, planifică o supracorecție și menține-o în faza de control.

Greșeală frecventă

Corectarea rotației fără a include dintele respectiv în planul de contenție.

CAZUL 27 Rotația nu se ameliorează nici după schimbarea arcurilor

Simptom: Dintele rotat rămâne în aceeași poziție după mai multe etape de arcuri.

CAUZE POSIBILE

- Arcul nu stă complet în slot (ligatură laxă).
- Nu există spațiu pentru rotație.
- Bracketul nu este centrat pe dinte.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Adaptarea arcului în slot
- [ ] Spațiul la punctele de contact vecine
- [ ] Poziția meziodistală a bracketului

DE FĂCUT

1. Asigură-te că arcul este complet ligaturat în slot.
2. Creează spațiu pentru rotație.
3. Dacă poziția bracketului este incorectă, repoziționează-l.
4. Dacă este necesar, adaugă un dispozitiv auxiliar de rotație și scurtează intervalul de control.

Când să ceri o opinie de specialitate: Dacă dintele nu se mișcă deloc, evaluează posibilitatea unei anchiloze (Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză).

CAZUL 28 Rotația s-a ameliorat, dar a revenit la următorul control

Simptom: Dintele care era în regulă la controlul anterior s-a rotat din nou.

CAUZE POSIBILE

- Ligatura s-a rupt sau s-a slăbit.
- S-a trecut la un arc mai flexibil.
- Fibrele parodontale trag dintele în poziția anterioară.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Integritatea ligaturii
- [ ] Arcul utilizat
- [ ] Dacă pacientul a semnalat desprinderea vreunui element

DE FĂCUT

1. Fixează ligatura în siguranță.
2. Menține un arc rigid pe parcursul mai multor controale.
3. Planifică o supracorecție.
4. Marchează separat acest dinte în planul de contenție.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă dintele rotat prezintă probleme gingivale pronunțate, solicită o opinie parodontologică.

CAZUL 29 Recidiva rotației în perioada de contenție

Simptom: Tratamentul s-a finalizat; după câteva luni, dintele inițial rotat s-a deplasat.

CAUZE POSIBILE

- Aparatul de contenție nu a fost purtat regulat.
- Retainerul lingual fix s-a dezlipit sau nu susține acest dinte.
- Nu a existat o supracorecție.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Retainerul este intact și adaptat?
- [ ] Dinții susținuți de retainerul fix
- [ ] Gradul recidivei

DE FĂCUT

1. Măsoară și notează recidiva.
2. Înlocuiește sau repară aparatul.
3. În caz de recidivă ușoară, folosește un aparat de contenție de control; în caz de recidivă pronunțată, discută opțiunile de retratament.
4. Revizuiește planul conform Ghidului 2 · Manual de Contenție Ortodontică.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă recidiva este însoțită de pierderea suportului parodontal, solicită o opinie parodontologică.

CAZUL 30

S-a deschis punctul de contact vecin în timpul corecției rotației

Simptom: A apărut un mic spațiu lângă dintele rotat sau dintele vecin a alunecat.

CAUZE POSIBILE

- Forța utilizată pentru rotație s-a transmis dintelui vecin.
- Lățimea dintelui (dimensiunea meziodistală) s-a modificat odată cu rotația.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Punctele de contact
- [ ] Poziția dintelui vecin
- [ ] Mărimea spațiului rezidual

DE FĂCUT

1. Solidarizează pasiv segmentul.
2. Închide spațiul apărut în mod controlat.
3. Adaugă verificarea punctelor de contact pe lista de finalizare.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** Dacă spațiul deschis provine dintr-o anomalie de formă restaurativă, stomatologie restaurativă.

MODULUL 08

Dintele inclus nu erupe

Dintele inclus nu se mișcă în ciuda tracțiunii, a apărut o problemă la dintele vecin sau există spațiu, dar dintele tot nu erupe.

În cazul dinților incluși, cel mai important control este înregistrarea succesivă a direcției și a gradului de deplasare a dintelui. Dacă nu există mișcare, caută imediat cauza.

Greșeală frecventă

Continuarea tracțiunii prin creșterea forței pe un dinte care nu se mișcă.

CAZUL 31 Caninul inclus nu răspunde la tracțiune

Simptom: Tracțiunea a început; de la mai multe controale nu există nicio mișcare clinică sau radiologică.

CAUZE POSIBILE

- Anchiloză.
- Direcția tracțiunii este greșită; dintele este tras spre rădăcina vecină.
- Fixarea attachment-ului s-a desprins.
- Obstacol osos sau de țesut moale.

CE VERIFICI

- [ ] Schimbarea de poziție pe imaginile seriate
- [ ] Direcția tracțiunii
- [ ] Integritatea fixării
- [ ] Raportul cu rădăcinile vecine

DE FĂCUT

1. Verifică fixarea.
2. Reproiectează direcția tracțiunii astfel încât dintele să se îndepărteze de rădăcinile vecine.
3. Nu crește forța.
4. Dacă nu există mișcare, evaluează situația și suspiciunea de anchiloză cu imagistică suplimentară.

Când să ceri un aviz de specialitate: La suspiciune de anchiloză sau de resorbție radiculară, ori dacă este necesară o nouă expunere chirurgicală, decizie comună cu un chirurg oro-maxilo-facial.

CAZUL 32 În timpul tracțiunii, incisivul vecin a devenit mobil

Simptom: În timpul tragerii canimului inclus, incisivul lateral este sensibil și se mișcă.

CAUZE POSIBILE

- Canimul vine în contact cu rădăcina incisivului vecin.
- Pe rădăcina vecină poate fi începută o resorbție.

CE VERIFICI

- [ ] Mobilitatea și sensibilitatea dintelui vecin
- [ ] Raporturile radiculare pe radiografie

DE FĂCUT

1. Oprește temporar tracțiunea.
2. Evaluează raporturile radiculare cu imagistică suplimentară.
3. Reproiectează direcția tracțiunii.
4. Notează situația și explic-o pacientului.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** La suspiciune de resorbție radiculară, evaluare comună cu un chirurg oro-maxilo-facial și cu un ortodont cu experiență.

CAZUL 33 Există loc, dar premolarul sau al doilea molar nu erupe

Simptom: Spațiul necesar există; la momentul așteptat dintele nu a erupt.

CAUZE POSIBILE

- Obstacol al erupției: os, țesut moale, rădăcină de dinte temporar.
- Tulburare primară de erupție.
- Anchiloză.

CE VERIFICI

- [ ] Poziția radiologică și dezvoltarea rădăcinii
- [ ] Rest de dinte temporar
- [ ] Comparația cu partea opusă

DE FĂCUT

1. Identifică obstacolul.
2. În cazul unui rest de dinte temporar, ia în calcul îndepărtarea.
3. Planifică o monitorizare pe o perioadă stabilită și notează-o.
4. Dacă nu există progres, cere evaluare chirurgicală.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** La suspiciune de obstacol al erupției sau de tulburare primară de erupție, chirurgie oro-maxilo-facială; la copii, aviz de pedodonție.

CAZUL 34

Problemă gingivală la dintele adus prin tracțiune

Simptom: Dintele a intrat în arcadă, dar gingia este îngustă, inflamată sau fixarea attachment-ului se desprinde mereu.

CAUZE POSIBILE

- Tehnica expunerii chirurgicale nu a fost favorabilă gingiei.
- Igienă insuficientă.
- Fixarea se desprinde în mod repetat.

CE VERIFICI

- [ ] Lățimea gingiei fixe
- [ ] Placa bacteriană și sângerarea
- [ ] Starea fixării

DE FĂCUT

1. Consolidează igiena și notează.
2. Înlocuiește fixarea.
3. Documentează starea gingiei.
4. În cazul unei probleme gingivale persistente, decide trimiterea.

> **Când să ceri un aviz de specialitate:** În caz de gingie fixă insuficientă sau de inflamație care nu se vindecă, parodontologie.

CAPITOLUL 09

Suspiciune de resorbție radiculară

Scurtarea rădăcinii pe imaginea de control, mobilitate în creștere sau modificare la un dinte traumatizat.

La suspiciunea de resorbție radiculară nu ai nevoie de panică, ci de sistem: comparație, notare, controlul forței și, la nevoie, o pauză.

Greșeală frecventă

Să decizi fără comparația cu radiografia inițială.

CAZUL 35 Pe panoramica de control rădăcinile incisivilor par scurte

Simptom: Pe panoramica de control intermediară, rădăcinile incisivilor superiori sunt mai scurte decât la început.

CAUZE POSIBILE

- Resorbție apicală reală.
- Diferență de proiecție; distorsiune pe imaginea panoramică.
- Durată lungă de tratament, mișcare radiculară mare.

CE VERIFICI

- [ ] Comparația cu imaginea inițială, cu aceeași tehnică
- [ ] Mobilitatea
- [ ] Antecedente traumatice
- [ ] Mișcarea radiculară efectuată în timpul tratamentului

DE FĂCUT

1. Realizează o imagine comparativă cu aceeași tehnică.
2. În cazul unei resorbții reale, redu forțele și, la nevoie, fă o pauză în tratamentul activ.
3. Reevaluează obiectivele; redu mișcarea rămasă.
4. Explică situația pacientului și notează.
5. Planifică intervalul imagisticii de control.

Când să ceri un aviz de specialitate: În caz de resorbție pronunțată sau progresivă, cere avizul unui ortodont cu experiență și al unui endodont.

CAZUL 36 Mobilitatea dintelui a crescut în timpul tratamentului

Simptom: Unul sau mai mulți dinți se mișcă mai mult decât era de așteptat.

CAUZE POSIBILE

- Traumă ocluzală (contact prematur).
- Inflamație parodontală.
- Resorbție radiculară.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Contact prematur
- [ ] Adâncimea pungilor parodontale și sângerarea
- [ ] Rădăcina și osul pe radiografie

ACȚIUNI

1. Elimină contactul prematur.
2. Evaluează starea parodontală.
3. Verifică rădăcina prin radiografie.
4. Redu forțele și monitorizează starea.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de semne de distrucție parodontală, consultă un parodontolog; în caz de suspiciune de resorbție, solicită opinia unui endodont.

CAZUL 37 Decolorare sau sensibilitate la un dinte cu istoric de traumatism

Simptom: Întunecarea unui dinte care a suferit un traumatism în trecut, sensibilitate la percuție.

CAUZE POSIBILE

- Pulpa își pierde vitalitatea.
- Simptom tardiv al unui traumatism vechi.
- Forța ortodontică solicită dintele traumatizat.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Teste de vitalitate
- [ ] Percuție și palpare
- [ ] Regiunea periapicală și rădăcina pe radiografie

ACȚIUNI

1. Redu forța aplicată pe acest dinte.
2. Documentează vitalitatea.
3. Solicită opinia unui endodont și decideți împreună asupra tratamentului.
4. Înregistrează decizia și procesul (Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză).

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de pierdere a vitalității sau modificări periapicale, consultă un endodont; în caz de suspiciune de anchiloză, solicită opinia unui specialist.

MODULUL 10

Lipsa purtării elasticelor

Pacientul nu poartă elasticele, le aplică incorect, renunță la ele sau lipsește de la programări.

Problema de cooperare nu este una mecanică, ci una de comunicare. Instrucțiunile trebuie să fie simple, scrise și măsurabile.

Greșeală frecventă

Să observi lipsa cooperării și să modifici mecanica în loc să discuți deschis cu pacientul.

CAZUL 38 Pacientul nu poartă elasticele

Simptom: Punga cu elastice este aproape plină, nu există uzură pe cârlige, nu există progres.

CAUZE POSIBILE

- Nu a înțeles instrucțiunile.
- Aplicarea elasticelor este dificilă sau dureroasă.
- Lipsa motivației; pacientul nu cunoaște scopul.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Pune pacientul să aplice elasticele în fața ta
- [ ] Există durere sau leziuni?
- [ ] Lasă pacientul să explice cu cuvintele lui de ce nu le poartă

ACȚIUNI

1. Pune-l să aplice elasticele o dată în fața ta.
2. Explică scopul într-o singură frază: „Aceste elastice îți corectează mușcătura.”
3. Oferă un calendar simplu, scris, și analizați-l împreună la următoarea vizită.
4. În cazul pacienților copii, implică și familia.
5. Dacă nu există cooperare, spune-i deschis și consemnează în fișă că, din acest motiv, tratamentul se prelungește.

Când să ceri o opinie de specialitate: Dacă cooperarea nu se îmbunătățește, evaluează împreună cu un ortodont experimentat opțiunile mecanice care depind mai puțin de cooperare.

CAZUL 39 Pacientul poartă elasticele, dar în configurație greșită

Simptom: Pacientul poartă elasticele, dar mușcătura se modifică într-o direcție neașteptată.

CAUZE POSIBILE

- Aplică elasticul pe cârligul greșit.
- Încurcă partea dreaptă cu cea stângă.
- Nu are instrucțiuni scrise.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Pune-l să le aplice și verifică configurația
- [ ] Direcția modificării mușcăturii

ACȚIUNI

1. Arată-i aplicarea corectă.
2. Oferă instrucțiuni scrise cu un desen simplu.
3. Verifică din nou la următoarea vizită.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** De regulă nu este necesar; se rezolvă prin comunicare.

CAZUL 40 Elasticul se rupe constant sau pacientul renunță din cauza durerii

Simptom: Pacientul spune că elasticul se rupe sau provoacă durere.

CAUZE POSIBILE

- Dimensiunea sau forța elasticului nu este adecvată.
- Cârligul este ascuțit și se înfige în țesut.
- Nu știe cât de des trebuie să schimbe elasticele.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Starea cârligelor
- [ ] Leziuni pe mucoasa jugală sau buze
- [ ] Obiceiul pacientului de a schimba elasticele

ACȚIUNI

1. Corectează cârligul ascuțit.
2. Revizuiește dimensiunea și forța elasticului.
3. Specifică frecvența de schimbare în scris.
4. Explică faptul că sensibilitatea în primele zile poate fi normală.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de leziuni care nu se vindecă, solicită evaluarea medicului competent.

CAZUL 41

Pacient care lipsește de la programări: se pierde controlul asupra cazului

Simptom: Pacientul a ratat mai multe programări; lanțul s-a slăbit, bracketii s-au dezlipit, progresul s-a oprit.

CAUZE POSIBILE

- Programul vizitelor nu se potrivește pacientului.
- Pacientul nu înțelege de ce se prelungește tratamentul.
- La intervale lungi de control, mecanica rămâne neverificată.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Ce s-a schimbat de la ultimul control?
- [ ] Bracket dezlipit sau aparat deteriorat
- [ ] Igiena

DE FĂCUT

1. Înregistrează situația și arată-i-o deschis pacientului.
2. Adu mecanica într-o stare sigură (ligaturare pasivă).
3. Stabilește un calendar realist.
4. Notează în scris faptul că ședințele omise prelungesc durata tratamentului.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** De regulă nu este necesară; se poate gestiona prin comunicare clinică și programări.

CAPITOLUL 11

Probleme cu aparatele ortodontice

În cazul aparatelor de expansiune, funcționale și de ancoraj, efectul scontat întârzie să apară, apare recidiva sau aparatul în sine cauzează probleme.

Problemele legate de aparat provin cel mai des din trei surse: indicație, cooperare și integritatea aparatului. Verifică toate cele trei aspecte la fiecare control.

Greșeală frecventă

Să vezi aparatul în gură și să presupui că funcționează; să nu măsori activarea și efectul.

CAZUL 42 Expansiune insuficientă după RME

Simptom: Șurubul a fost activat; nu s-a format diastema mediană, distanța dintre molari s-a modificat abia sesizabil.

CAUZE POSIBILE

- Sutura este matură; răspunsul scheletal este limitat.
- Șurubul nu a fost activat regulat.
- Benzile s-au slăbit; aparatul nu transmite forța către dinți.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Jurnalul de activare
- [ ] Adaptarea benzilor
- [ ] Radiografia ocluzală sau diastema mediană clinică
- [ ] Vârsta pacientului și stadiul de creștere

DE FĂCUT

1. Analizează jurnalul de activare împreună cu pacientul.
2. Verifică benzile și cimentul.
3. Diferențiază răspunsul dentar de cel scheletal.
4. Dacă nu există răspuns și sutura este matură, reevaluează planul.

Când să ceri o opinie de specialitate: La adulți, în caz de necesitate de expansiune scheletală, evaluare comună cu un ortodont experimentat sau chirurg pentru alte opțiuni.

CAZUL 43 Recidivă transversală după expansiune

Simptom: După expansiune, ocluzia inversă reapare.

CAUZE POSIBILE

- Timp de contenție insuficient.
- Expansiune realizată prin înclinare dentară; răspuns scheletal redus.
- Poziție joasă a limbii.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Înclinările molarilor
- [ ] Măsurătorile seriate ale lățimii arcadelor
- [ ] Poziția limbii

DE FĂCUT

1. Măsoară recidiva.
2. Aplică un aparat de contenție sau prelungește durata acesteia.
3. Verifică torque-ul molarilor.
4. Dacă este necesară o expansiune suplimentară, identifică cauza și planifică.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de suspiciune de probleme respiratorii, evaluare ORL.

CAZUL 44 Pacientul nu poartă aparatul funcțional mobil

Simptom: Aparatul nu prezintă urme de uzură; overjet-ul nu se modifică.

CAUZE POSIBILE

- Aparatul este inconfortabil sau împiedică vorbirea.
- Pacientul și familia nu cunosc scopul tratamentului.
- Timpul de purtare nu este clar.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Adaptarea aparatului și punctele de presiune
- [ ] Relatarea pacientului
- [ ] Măsurătorile seriate ale overjet-ului

DE FĂCUT

1. Corectează punctele de presiune.
2. Specifică în scris scopul și timpul de purtare.
3. Stabilește un calendar simplu împreună cu familia.
4. Dacă nu există cooperare, ia în considerare alternativele fixe.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** De regulă nu este necesară; dacă nu se îmbunătățește cooperarea, discută alternativele fixe cu un ortodont experimentat.

CAZUL 45 Aparatul funcțional fix se slăbește sau se rupe repetat

Simptom: Conexiunea aparatului telescopic sau funcțional fix se desface frecvent.

CAUZE POSIBILE

- Punctul de ancorare este slab.
- Aparatul este suprasolicitat la deschiderea mare a gurii.
- Arcurile nu sunt suficient de rigide.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Punctele de ancorare
- [ ] Piesa ruptă
- [ ] Dimensiunea arcului

DE FĂCUT

1. Reînnoiește ancorajul și întărește punctul respectiv.
2. Verifică deschiderea gurii; observă dacă aparatul se blochează la deschidere maximă.
3. Evaluează rigiditatea arcurilor.
4. Înregistrează rupturile repetate; urmărește tiparul în jurnal.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În caz de deschidere limitată a gurii sau dureri ATM, evaluare ATM.

CAZUL 46 Arcul transpalatinal sau Nance se înfige în mucoasă

Simptom: Presiune, roșeață pe mucoasa palatinală sau aparatul a fost înglobat în țesut.

CAUZE POSIBILE

- Aparatul este prea aproape de palat.
- Molarii s-au deplasat; poziția aparatului s-a modificat.
- Igienă insuficientă.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Ulcer și inflamație pe mucoasă
- [ ] Distanța dintre aparat și palat
- [ ] Adaptarea benzilor

ACȚIUNI

1. Îndepărtează aparatul de pe țesut sau scoate-l și confecționează unul nou.
2. Monitorizează vindecarea țesutului.
3. Repetă instrucțiunile de igienă.
4. Dacă este necesar ancoraj, planifică o soluție temporară.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** În cazul unei leziuni care nu se vindecă sau care se extinde, solicită o evaluare de chirurgie orală sau a medicului specialist competent.

MODULUL 12

Aliniatorul transparent nu se adaptează

Aliniatoarele nu se așază complet pe dinți, attachment-urile se desprind sau mișcarea planificată nu se realizează.

În cazul aliniatoarelor transparente, gestionarea blocajelor începe cu verificarea adaptării. Dacă există un spațiu între aliniator și dinte, mișcarea a ieșit de sub control.

Greșeală frecventă

Trecerea la faza următoare cu un aliniator care nu se adaptează.

CAZUL 47

Aliniatorul nu se așază complet pe dinte

Simptom: Spațiu între aliniator și suprafața dentară, în special la marginile incizale sau pe al doilea molar.

CAUZE POSIBILE

- Aliniatorul nu a fost purtat suficient timp.
- Mișcarea planificată nu s-a realizat biologic.
- Attachment-ul s-a desprins sau s-a uzat.
- Punctele de contact sunt strânse.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Pe care dinte nu există adaptare?
- [ ] Starea attachment-urilor
- [ ] Timpul zilnic de purtare
- [ ] Punctele de contact

ACȚIUNI

1. Evaluează revenirea la aliniatorul anterior sau așteptarea cu același aliniator.
2. Arată-i pacientului tehnica pentru a facilita adaptarea.
3. Înlocuiește attachment-ul.
4. Dacă adaptarea nu se realizează, planifică din nou cu o amprentă și un plan noi.

Când să ceri o opinie de specialitate: De regulă nu este necesar; refacerea planului este o decizie ortodontică.

CAZUL 48 Attachment-ul s-a desprins sau s-a uzat

Simptom: Lipsește attachment-ul de pe unul sau mai mulți dinți sau și-a pierdut forma.

CAUZE POSIBILE

- Pregătirea suprafeței de colaj a fost insuficientă.
- Pacientul forțează îndepărtarea aliniatoarelor.
- Contactul cu alimente dure.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Care attachment-uri s-au desprins?
- [ ] Adaptarea aliniatorului
- [ ] Cum scoate pacientul aliniatoarele?

ACȚIUNI

1. Refă attachment-ul folosind șablonul.
2. Arată-i pacientului tehnica de îndepărtare a aliniatorului.
3. Verifică adaptarea.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** De regulă nu este necesar.

CAZUL 49 Rotația sau extruzia planificată nu se realizează

Simptom: Crește discrepanța dintre plan și situația din cavitatea orală.

CAUZE POSIBILE

- Aliniatorul nu oferă suficientă retenție pentru această mișcare.
- Rotația este dificilă pe un dinte cu secțiune circulară.
- Nu există attachment sau acesta este necorespunzător.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Diferența dintre plan și situația din cavitatea orală
- [ ] Designul attachment-ului
- [ ] Timpul de purtare

ACȚIUNI

1. Înregistrează discrepanța.
2. Adaugă un attachment sau o mecanică auxiliară.
3. Dacă este necesar, planifică o fază scurtă de mecanică fixă.
4. Continuă cu un plan nou.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** De regulă nu este necesar; modificarea mecanicii este o decizie ortodontică.

CAZUL 50

Timp scăzut de purtare a aliniatorului

Simptom: Pacientul declară că scoate aliniatoarele pentru perioade lungi în timpul zilei.

CAUZE POSIBILE

- Nu cunoaște regulile.
- Aliniatorul este inconfortabil sau deranjează vorbirea.
- Obiceiuri alimentare.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Verificarea adaptării
- [ ] Programul zilnic al pacientului
- [ ] Starea aliniatorului

ACȚIUNI

1. Specifică obiectivul zilnic de purtare în scris.
2. Corectează marginile inconfortabile ale aliniatorului.
3. Consemnează complianța la fiecare control.
4. Dacă nu există complianță, explică faptul că tratamentul se va prelungi.

> **Când să ceri o opinie de specialitate:** De regulă nu este necesar.

MODULUL 13

Punctele de contact și rădăcinile la finalizare

Tratamentul se apropie de sfârșit, dar punctele de contact sunt deschise, rădăcinile nu sunt paralele sau ocluzia nu se stabilizează.

Depanarea finalizării necesită mai multă atenție decât restul tratamentului. Înainte de îndepărtarea bracket-urilor, completează checklist-ul.

Greșeală frecventă

Îndepărtarea bracket-urilor fără un control radiografic panoramic.

CAZUL 51 Punctele de contact rămân deschise

Simptom: Au rămas mici spații între dinții frontali sau laterali.

CAUZE POSIBILE

- Discrepanță Bolton.
- Rădăcinile nu sunt paralele.
- După închiderea spațiilor nu a existat o contenție pasivă.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Analiza Bolton
- [ ] Angularea rădăcinilor pe radiografia panoramică
- [ ] Punctele de contact

DE FĂCUT

1. Închide punctele de contact și solidarizează-le pasiv.
2. În caz de discrepanță de mărime dentară, planifică o soluție restaurativă.
3. Verifică paralelismul radicular.
4. Include această regiune în planul de contenție.

Când să ceri aviz de specialitate: Dacă este necesară remodelarea dinților mici, stomatologie restaurativă.

CAZUL 52 Rădăcinile nu sunt paralele pe radiografia panoramică

Simptom: Coroanele par aliniate; pe radiografia panoramică, rădăcinile converg sau diverg.

CAUZE POSIBILE

- Angulare incorectă a bracketului.
- Rădăcinile nu au fost închise paralel în regiunea extracțională.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Radiografia panoramică de finalizare
- [ ] Poziția bracketurilor

DE FĂCUT

1. Repoziționează bracketurile.
2. Oferă timp pentru mișcarea radiculară.
3. Efectuează o radiografie de control înainte de debonding.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** De regulă nu este necesar; decizie de finalizare ortodontică.

CAZUL 53 Crestele marginale nu sunt la același nivel

Simptom: Diferență de înălțime pronunțată între crestele marginale ale dinților adiacenți.

CAUZE POSIBILE

- Înălțime incorectă a bracketului.
- Formă coronară diferită.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Nivelul crestelor marginale
- [ ] Înălțimea bracketurilor
- [ ] Forma coronară

DE FĂCUT

1. Corectează înălțimea bracketului.
2. Ia în calcul mici îndoiri în arc (bends).
3. În cazul unor forme coronare diferite, ajustează nivelarea în funcție de acestea.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** În caz de anomalie a formei coronare, stomatologie restaurativă.

CAZUL 54

Ocluzia posterioară nu se stabilizează

Simptom: Relația cuspide-fosă nu este completă pe dinții laterali; puține puncte de contact.

CAUZE POSIBILE

- Arcul rigid nu permite așezarea dinților.
- Discrepanțe de torque.
- Contact prematur.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Puncte de contact
- [ ] Torque molar și premolar
- [ ] Contact prematur

DE FĂCUT

1. Planifică o fază de așezare (settling).
2. Dacă este necesar, ia în calcul elastice ușoare de așezare.
3. Verifică contactele premature.
4. Fixează ocluzia și treci la contenție.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** În caz de simptome ATM de origine ocluzală, evaluare de către medicul specialist corespunzător.

MODULUL 14

Probleme transversale

Ocluzia inversă sau ocluzia în foarfecă nu se ameliorează; arcul se lărgește excesiv.

Diferențiază problema transversală în componentă scheletală și dentară. Fără această diferențiere, expansiunea fie va recidiva, fie va forța limita parodontală.

Greșeală frecventă

Rezolvarea problemei transversale doar prin înclinarea dinților.

CAZUL 55 Ocluzia inversă posterioară nu se ameliorează

Simptom: S-a efectuat expansiune sau mecanică; ocluzia inversă persistă.

CAUZE POSIBILE

- Problema este scheletală; mecanica dentară nu este suficientă.
- Există o deviație funcțională.
- Molarii sunt înclinați vestibular, dar baza osoasă nu s-a modificat.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Ocluzia inversă în relație centrică
- [ ] Înclinația molarilor
- [ ] Lățimea maxilară

DE FĂCUT

1. Stabilește dacă există o deviație funcțională.
2. Diferențiază componenta scheletală de cea dentară.
3. Limitează înclinarea dentară.
4. Dacă este necesar, planifică expansiunea scheletală.

Când să ceri aviz de specialitate: În caz de îngustare scheletală la adult, evaluare comună cu un ortodont experimentat sau chirurg.

CAZUL 56 Ocluzia în foarfecă nu se ameliorează

Simptom: Premolarul sau molarul superior este poziționat vestibular față de dintele inferior; corecția stagnează.

CAUZE POSIBILE

- Contactul ocluzal împiedică mișcarea.
- Mecanica acționează doar pe un singur arc.
- Ancoraj insuficient.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Contact ocluzal
- [ ] În ce direcție trebuie să se miște fiecare dinte?

DE FĂCUT

1. Elimină contactul prin înălțarea temporară a ocluziei.
2. Dacă este necesar, planifică mecanică pe ambele arcuri.
3. Evaluează ancorajul.
4. Fixează progresul.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** De regulă nu este necesar; decizie mecanică.

CAZUL 57 Lățimea arcului a crescut excesiv în timpul nivelării

Simptom: În timpul rezolvării înghesuirii, lățimea arcului și distanța intercanină au crescut.

CAUZE POSIBILE

- Necesarul de spațiu a fost satisfăcut prin expansiune.
- Forma arcului nu se potrivește cu forma arcadei pacientului.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Distanța intercanină și intermolară
- [ ] Forma inițială a arcadei
- [ ] Gingia vestibulară

ACȚIUNI

1. Alege forma arcului în funcție de forma inițială.
2. Recalculează necesarul de spațiu.
3. Reevaluează posibilitatea de IPR sau extracție.
4. Monitorizează modificările gingiei vestibulare.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** La debutul recesiunii gingivale vestibulare, consultă parodontologia.

CAPITOLUL 15

Probleme parodontale și de igienă

Leziunile de tip „white spot", hipertrofia gingivală sau recesiunea gingivală pun în pericol tratamentul.

Dacă țesuturile nu sunt sănătoase, deplasarea dentară devine riscantă. Igiena nu este o problemă privată a pacientului, ci o parte integrantă a tratamentului.

Greșeală frecventă

Să nu înregistrezi problema de igienă, să nu o arăți pacientului și să continui mecanica.

CAZUL 58 Debutul leziunilor de tip „white spot" în jurul bracketului

Simptom: Zone de demineralizare mate, albe, în jurul bracketului.

CAUZE POSIBILE

- Periaj insuficient.
- Consumul de alimente și băuturi zaharoase.
- Exces de adeziv în jurul bracketului.

CE SĂ VERIFICI

- ☐ Localizarea și numărul leziunilor
- ☐ Indicele de placă
- ☐ Obiceiurile alimentare

ACȚIUNI

1. Documentează leziunile prin fotografii sau pe o diagramă.
2. Arată-i pacientului în oglindă și reînvață-l tehnica de periaj.
3. Stabilește un plan de tratament preventiv împreună cu colegul responsabil.
4. Monitorizează igiena la fiecare interval de control.
5. Dacă igiena nu se îmbunătățește, discută deschis cu pacientul despre continuarea tratamentului.

Când să ceri aviz de specialitate: În caz de cavitație sau carie activă, consultă stomatologia restauratoare.

CAZUL 59 Hipertrofia gingivală împiedică mecanica

Simptom: Gingia acoperă bracketurile și lanțurile; închiderea spațiilor încetinește.

CAUZE POSIBILE

- Acumularea de placă.
- Iritație în jurul inelului sau al lanțului.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Sângerare și hipertrofie
- [ ] Placă bacteriană
- [ ] Regiunile afectate

ACȚIUNI

1. Consolidează igiena.
2. Planifică o igienizare profesională cu colegul responsabil.
3. Verifică sursele de iritație.
4. Dacă hipertrofia nu dispare, trimite pacientul la specialist.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** Pentru hipertrofia gingivală care nu se ameliorează prin igienă, consultă parodontologia.

CAZUL 60 Debutul recesiunii gingivale pe suprafața vestibulară a incisivilor inferiori

Simptom: Nivelul gingival a coborât pe suprafața vestibulară a dinților frontali inferiori.

CAUZE POSIBILE

- Deplasarea vestibulară a incisivilor.
- Biotip gingival subțire.
- Periaj agresiv.

CE SĂ VERIFICI

- [ ] Nivelul gingival și gingia aderentă
- [ ] IMPA
- [ ] Tehnica de periaj

ACȚIUNI

1. Măsoară și înregistrează starea actuală.
2. Limitează proclinația incisivilor.
3. Corectează tehnica de periaj.
4. Solicită un aviz parodontal și decideți împreună calea de urmat.

> **Când să ceri aviz de specialitate:** În caz de recesiune gingivală progresivă sau gingie aderentă insuficientă, consultă parodontologia.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul medicului specialist.

Pasul următor

Acum deschide **Atlasul de Depanare Mecanică**: vei găsi cauzele mecanice din spatele scenariilor de aici, organizate pe teme și în tabele. Înregistrează fiecare caz blocat în **Jurnalul de Cazuri** și, pentru reconstrucția planului, revino la **Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică**.